

尿道憩室是指在尿道（将尿液排出体外的管道）旁形成的一个小囊袋，几乎只发生于女性。少量尿液可积存其中，导致尿后滴沥、不适、反复感染或性交疼痛。该病常被漏诊多年，但一经确诊，治疗效果良好。

关于这种疾病

经典表现为"三D症状"：

- **滴沥（Dribbling）** — 排尿结束后仍有少量尿液漏出
- **排尿痛（Dysuria）** — 排尿时有烧灼感或不适
- **性交痛（Dyspareunia）** — 性生活时疼痛

其他表现包括**反复尿路感染**、尿急、尿频，或阴道前壁可触及压痛性包块，按压时可有液体溢出。

病因

通常认为，尿道周围的小腺体发生**阻塞和感染**，随后破入尿道，形成积存尿液的囊袋。该病不是肿瘤，也与个人行为无关。

名词解释

尿道

将尿液排出体外的管道。

憩室

从空腔管道向外膨出的囊袋。

"三D症状"

滴沥、排尿痛（烧灼感）和性交痛。

MRI

术前定位囊袋最佳的影像检查。

憩室切除术

切除囊袋并修复尿道的手术。

Martius瓣

有时用于加固修复的小组织瓣。

膀胱镜检查

用细镜头观察尿道和膀胱内部。

我需要手术吗？ 不一定。无症状的小憩室可定期观察。但若出现滴沥、反复感染、疼痛或明显包块，则建议行憩室切除术（diverticulectomy）作为根治性治疗。医生会先用MRI详细评估憩室的大小和位置。

如何诊断

- 体格检查 — 阴道前壁可触及压痛性包块，按压时可有液体溢出
- **MRI** — 最佳影像方法，可清晰显示囊袋的大小和形态
- 必要时行**膀胱镜检查**，从内部观察憩室开口

如何治疗

- 1 **观察随访**：适用于无症状的小憩室。
- 2 **先控制感染**：如存在感染，需先治疗。
- 3 **憩室切除术** — 经阴道手术切除囊袋，并分层仔细修复尿道，必要时使用小组织瓣加固。
- 4 术后留置**导尿管**等待愈合，拔管前通常需行**愈合X线检查**。

重要提示

- 修复手术精细，术后通常需留置导尿管数周。
- 大多数患者症状明显改善；偶有憩室复发或出现新的漏尿，可进一步处理。
- 手术一般在感染控制后择期进行。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 发热、寒战或盆腔疼痛加重
- **无法排尿**，或导尿管引流停止（术后）
- 大量出血，或出现新的持续性漏尿

需要记住的三件事

1. 尿道憩室是尿道旁的小囊袋 — 记住“3D症状”（滴沥、烧灼感、性交痛）和反复感染的特点。
2. MRI是最佳定位手段。无症状的小憩室可观察；有症状者行精细手术切除修复。
3. 术后需留置导尿管并行愈合X线检查。如出现发热、无法排尿或持续性新发漏尿，请及时就医。